

CAPÍTULO 8.13

Lesiones Hepáticas

PERFIL EUNACOM 1.06.2.001
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Abdomen Agudo: Apendicitis y Diverticulitis

Apendicitis Aguda

Clínica Clásica

- **Dolor umbilical** (cólico) → migra en 24–48 h al **fosa ilíaca derecha** (FID) — epigastrio → periumbilical → FID
- Náuseas y vómitos (después del dolor, no antes)
- **Anorexia** (característica)
- Fiebre (baja al inicio, alta si hay perforación)
- **Signos de irritación peritoneal** en FID

Signos Claves

TABLA 8.13.1: SIGNO VS DESCRIPCIÓN		
SIGNO	DESCRIPCIÓN	QUÉ SUGIERE
McBurney	Dolor al presionar McBurney (unión 1/3 ext – 2/3 int entre ombligo y EIAS)	Apendicitis
Blumberg (rebote)	Dolor al soltar la presión bruscamente	Peritonitis
Rovsing	Dolor en FID al comprimir FII	Apendicitis
Psoas	Dolor al extender cadera derecha	Apéndice retrocecal
Obturator	Dolor al rotar cadera derecha	Apéndice pélvico

Diagnóstico

- **Clínico:** es el pilar fundamental. Puntaje de Alvarado (> 7 puntos = apendicitis)
- **Eco abdominal:** si duda diagnóstica (especialmente en mujer en edad fértil → descartar patología ovárica)
- **TAC abdomen:** si eco no conclusivo → gold standard para adultos con duda diagnóstica

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En pediatría y mujeres en edad fértil: eco primero. En adultos hombres con clínica clara → clínica sola puede ser suficiente para indicar cirugía.

Tratamiento

- **Apendicitis simple:** apendicectomía laparoscópica (electiva si plastron → primero antibióticos)
- **Apendicitis perforada:** apendicectomía de urgencia + lavado peritoneal + antibióticos

Plastrón Apendicular

- **Definición:** masa palpable en FID por adherencias del epiplón al apéndice inflamado (proceso localizado)
- **Diagnóstico:** clínica + eco/TAC
- **Tratamiento:** primero antibióticos (ceftriaxona + metronidazol) durante 6-8 semanas → luego apendicectomía electiva

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Plastron apendicular ≠ apendicitis perforada. El plastron está contenido → se puede manejar médico primero. La perforación libre → cirugía urgente.

Diagnóstico Diferencial en FID

TABLA 8.13.2: DIAGNÓSTICO VS CLAVE	
DIAGNÓSTICO	CLAVE
Salpingitis / EPI	Mujer en edad fértil, flujo, dolor bilateral, sin anorexia
Embarazo ectópico	Mujer, retraso menstrual, dolor súbito
Patología ovárica	Mujer, dolor cíclico, sin fiebre
Enfermedad de Crohn	Cuadro crónico recurrente, joven

Enfermedad Diverticular

Diverticulosis (No Complicada)

- **Definición:** divertículos en colon (protrusiones de mucosa por zonas débiles de la pared)
- **Ubicación más frecuente:** colon sigmoides (izquierdo)
- **Clínica:** asintomática o molestias vagas en FII
- **Hallazgo casual** en colonoscopia o enema baritado
- **Tratamiento:** dieta rica en fibra, hidratación

Diverticulitis Aguda (Complicada)

- **Clínica:**
 - - Dolor en **fosa ilíaca izquierda** (FII) — "apendicitis del lado izquierdo"
 - - Fiebre
 - - Cambio del hábito intestinal (constipación o diarrea)
 - - Puede asociarse a hematoquecia
- **Diagnóstico:** **TAC abdomen con contraste** (de elección)
 - - Muestra: engrosamiento de pared del colon sigmoides + estrías de grasa pericolónica

NOTA CLÍNICA

La colonoscopia está **contraindicada** en el episodio agudo de diverticulitis (riesgo de perforación). Se hace después de 6-8 semanas de resolución para descartar cáncer.

Clasificación de Hinchey

TABLA 8.13.3: GRADO VS DESCRIPCIÓN		
GRADO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO
I	Absceso pericolónico (< 3 cm)	Antibióticos EV + drenaje percutáneo
II	Absceso pélvico o distante	Antibióticos EV + drenaje percutáneo
III	Peritonitis purulenta	Cirugía urgente
IV	Peritonitis fecal (perforación libre)	Cirugía urgente

Tratamiento

TABLA 8.13.4: SITUACIÓN VS TRATAMIENTO	
SITUACIÓN	TRATAMIENTO
Grado I-II	ATB EV (ceftriaxona + metronidazol) + drenaje percutáneo guiado por TAC
Grado III-IV	Cirugía de urgencia: resección sigmoidea + colostomía (operación de Hartmann)
Post-episodio (6-8 semanas)	Colonoscopia para descartar cáncer + colectomía electiva si tiene > 2 episodios

Complicaciones

- **Absceso pericólico** (Hinchey I-II)
- **Peritonitis** (Hinchey III-IV)
- **Fístula colovesical**: neumaturia (gases por la orina) — hallazgo patognomónico
- **Obstrucción intestinal** (por estenosis post-inflamatoria)
- **Hemorragia** (sin inflamación → diverticulosis hemorrágica)

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Fístula colovesical = neumaturia. Hombre mayor con infecciones urinarias fecurentes y gas en orina → pensar en fístula colovesical por diverticulitis.

Resumen: FID vs. FII

TABLA 8.13.5: CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS CLÍNICOS		
	APENDICITIS	DIVERTICULITIS
Lado	FID	FII
Examen	Eco/TAC	TAC (eco menos útil)
Tratamiento	Cirugía	ATB ± cirugía según Hinchey

| Colonoscopia | Después de resolución | Después de resolución |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Mujer de 30 años usuaria de anticonceptivos orales combinados por 10 años se realiza ecografía abdominal por cólico renal que describe incidentalmente una masa hepática solitaria de 4.5 cm en lóbulo derecho. RMN con contraste muestra lesión hipervascular con captación precoz en fase arterial y lavado en fase venosa, sin cicatriz central."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Adenoma Hepático: tumor benigno fuertemente asociado al uso prolongado de anticonceptivos orales en mujeres jóvenes. Tiene riesgo de rotura con hemoperitoneo y transformación maligna a hepatocarcinoma (especialmente si es > 5 cm). Conducta: suspender inmediatamente los anticonceptivos orales; si mide > 5 cm, es sintomático o no regresa, se indica resección quirúrgica.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Quiste simple: anecogénico sin borde/tabique → observar; con borde/tabique → hidatídico → albendazol + cirugía
- Absceso amebiano: metronidazol sin drenaje; bacteriano: ceftriaxona + metronidazol + drenaje obligatorio
- Hemangioma: hiperecogénico homogéneo → observar (cirugía solo si >10cm)
- Adenoma: hipoeecogénico único homogéneo → resecar (riesgo de hepatocarcinoma)
- Hepatocarcinoma: heterogéneo irregular en DHC → cirugía o trasplante
- Resumen eco: anecogénico=quiste, hiperecogénico=hemangioma, hipoeecogénico único=adenoma, múltiples=metástasis
- Pólipos vesiculares: colesterolínico (<1cm, homogéneo)=seguimiento; neoplásico (>1cm, heterogéneo)=colecistectomía
- Sospecha de cáncer de vesícula = cirugía abierta (no laparoscópica)

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (LESIONES HEPÁTICAS)

PREGUNTA 1

En una ecografía abdominal se encuentra una lesión hepática hiperecogénica, homogénea, de 3 cm. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta?

- A)** Quiste simple; observar
- B)** Hemangioma hepático; observar
- C)** Adenoma hepático; resecar
- D)** Metástasis hepática; TAC
- E)** Hepatocarcinoma; cirugía

PREGUNTA 2

Paciente con fiebre, dolor en hipocondrio derecho e ictericia leve. La ecografía muestra una lesión quística hipoecogénica irregular en el hígado sin flujo al Doppler. Se sospecha absceso amebiano. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

- A)** Ceftriaxona + metronidazol + drenaje
- B)** Metronidazol endovenoso
- C)** Drenaje quirúrgico únicamente
- D)** Albendazol por 6 semanas
- E)** Antibióticos orales ambulatorios

PREGUNTA 3

Se encuentra un pólipo vesicular de 15 mm, heterogéneo, asociado a colelitiasis. ¿Cuál es la conducta?

- A)** Seguimiento ecográfico en 6 meses
- B)** Colectectomía laparoscópica
- C)** Cirugía abierta
- D)** Ácido ursodeoxicólico
- E)** Biopsia percutánea

RESUMEN: LESIONES HEPÁTICAS

Clase sobre lesiones hepáticas focales y pólipos vesiculares. Se revisa el aspecto ecográfico y manejo de cada una: quiste simple (anecogénico, sin borde ni tabique, observar), quiste hidatídico (con membrana/tabiques, albendazol + cirugía), absceso hepático (hipoecogénico irregular sin flujo al Doppler), hemangioma (hiperecogénico homogéneo, observar), adenoma (hipoecogénico único homogéneo, resecar por riesgo de malignización) y hepatocarcinoma (heterogéneo irregular, cirugía/trasplante). Metástasis hepáticas: múltiples lesiones hipoecogénicas. Pólipos vesiculares: colesterolínicos (<1cm, homogéneos, seguimiento) vs neoplásicos (>1cm, heterogéneos, colectectomía). Sospecha de cáncer de vesícula = cirugía abierta.